HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱۰ — اسکالپ و ناحیه تمپورال

لایه‌های اسکالپ، عروق و اعصاب، فاسیای تمپورال و عضله تمپورالیس

جلسه ۱۰ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۱۰)، دکتر میرزایی
متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه
تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸
نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱۰)، دکتر میرزایی؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر برای تصاویر و توضیح‌های مستند استفاده شده است.

منابع تصویر

۹ قاب از جزوه درس ۳۰ قاب از نتر. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۰ فصل ۱۰ — جلسه ۱۰: لایه‌های اسکالپ، عروق و اعصاب، فاسیای تمپورال و عضله تمپورالیس ۴
۰۱ حدود و لایه‌های اسکالپ ۵
۰۲ ساختمان لایه‌ها و عضله اکسیپیتوفرونتالیس ۸
۰۳ پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی ۱۱
۰۴ خون‌رسانی اسکالپ و گیجگاه ۱۵
۰۵ تخلیه وریدی ۱۸
۰۶ وریدهای رابط و عصب‌دهی ۲۲
۰۷ نکات بالینی اسکالپ ۲۵
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۲۹
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۲۹

فصل ۱۰ · جلسه ۱۰

پوست سر و ناحیه گیجگاهی

جزوه درس · نتر

- ۷ مبحث · ۱۲ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه دهم

اسکالپ و ناحیه تمپورال

منبع درس: دکتر میرزایی، گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۱

حدود و لایه‌های اسکالپ

مبحث ۱ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حدود و لایه‌های اسکالپ

هدف یادگیری

حدود قدامی، خلفی و طرفی اسکالپ را مشخص کنید؛ پنج لایه را از سطح به عمق در تصویر دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

حدود قدامی، خلفی و طرفی اسکالپ را مشخص کنید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1

بسمه تعالی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1

اسکالپ

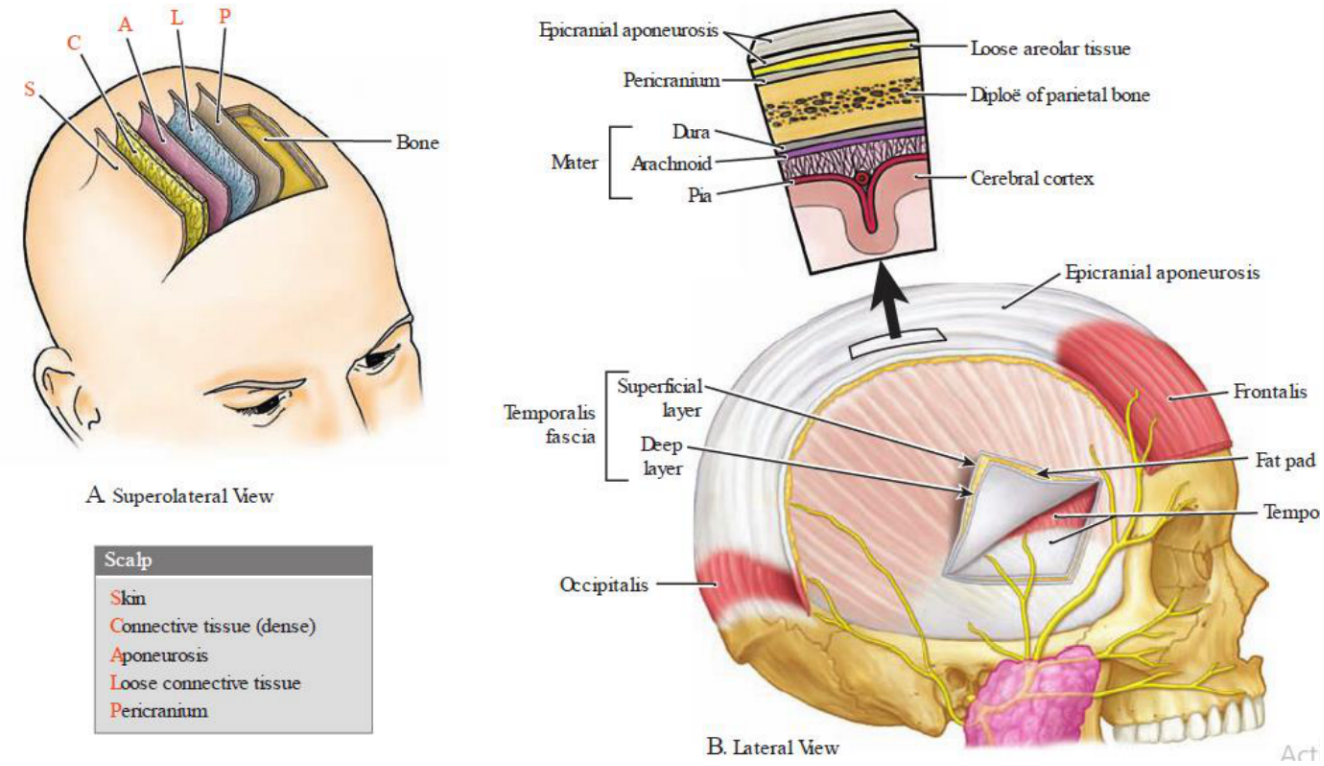
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1

شکل (۱) لایه‌های اسکالپ

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — حدود و لایه‌های اسکالپ

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1، شکل 01



لایه‌های سطحی و مقطع عمقی و نمای جانبی را با هم مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1، شکل 01

بافت‌های نرمی که سقف جمجمه را می‌پوشانند، اسکالپ نامیده می‌شوند. در جلو به حاشیه سوپرااوربیتال، در خلف به برجستگی اکسیپیتال خارجی و خطوط پشت گردنی (نوکال) فوقانی و در طرفین به خطوط تمپورال فوقانی محدود می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1

اسکالپ از ۵ لایه ساخته شده است. کلمه SCALP از حرف اول کلمات ذیل گرفته شده است: [ادامه در صفحه ۲]

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1

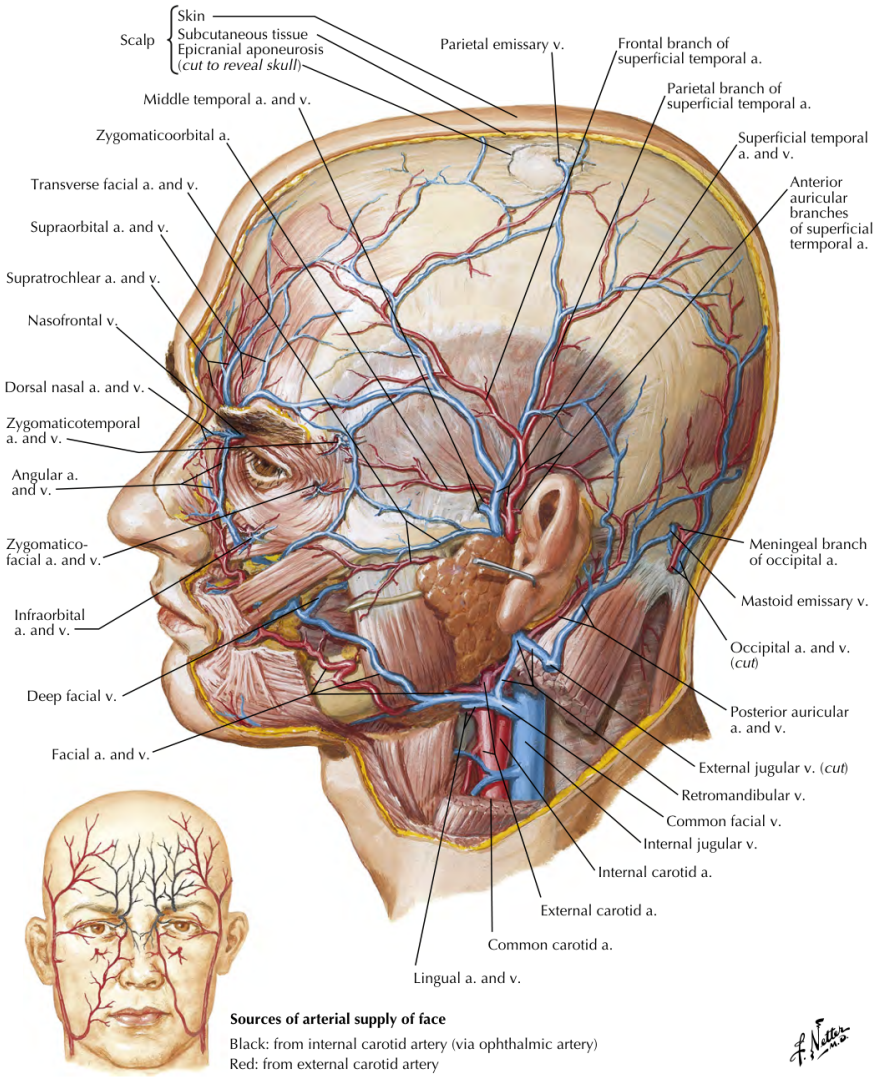
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در نمای جانبی نتر پوست، بافت زیرجلدی و آپونوروز در مجاورت رگ‌ها نشان داده شده‌اند؛ برای پنج لایه، شکل جزوه را نیز دنبال کنید.

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

نمای مرجع — حدود و لایه‌های اسکالپ

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۲۴، صفحه فایل 76



لایه‌های سطحی و رگ‌های تمپورال را در نمای جانبی بیابید.

ارجاع متن: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۲۴، صفحه فایل 76

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — حدود و لایه‌های اسکالپ

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 1؛ نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

- ☐ حدود قدامی، خلفی و طرفی اسکالپ را مشخص کنید.
- ☐ پنج لایه را از سطح به عمق در تصویر دنبال کنید.
- ☐ حروف SCALP را با نام هر لایه تطبیق دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در نمای جانبی نتر پوست، بافت زیرجلدی و آپونوروز در مجاورت رگ‌ها نشان داده شده‌اند؛ برای پنج لایه، شکل جزوه را نیز دنبال کنید.

پرسش باز: حدود قدامی، خلفی و طرفی اسکالپ را مشخص کنید؛ پنج لایه را از سطح به عمق در تصویر دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ساختمان لایه‌ها و عضله اکسیپیتوفرونتالیس

مبحث ۲ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ساختمان لایه‌ها و عضله اکسیپیتوفرونتالیس

هدف یادگیری

بطن‌های فرونتال و اکسیپیتال را به آپونوروز متصل کنید؛ فضای زیرآپونوروتیک را نسبت به پلک بالا بیابید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

بطن‌های فرونتال و اکسیپیتال را به آپونوروز متصل کنید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

a) پوست (Skin)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

b) فاسیای سطحی (superficial fascia) یا بافت همبند (Connective tissue)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

c) فاسیای عمقی (deep fascia) که به شکل آپونوروز اپی‌کرانیال (epicranial aponeurosis) یا نیام گالهآ (galea aponeurotica) بوده و همراه با عضله اکسیپیتوفرونتالیس می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

d) بافت همبند سست (Loose aveolar tissue)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

e) پری‌کرانیوم (Pericranium)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

پوست، ضخیم و پر مو است. پوست از طریق فاسیای سطحی محکم به نیام اپی‌کرانیال همانند کف پا و کف دست متصل شده است. فاسیای سطحی یا زیرجلدی در مرکز سر نسبت به محیط سر فیبروزتر و محکم‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

این فاسیا پوست را به آپونوروز زیرین خود متصل می‌کند و فضایی را برای عبور عروق و اعصاب پوست فراهم می‌کند. عضله اکسیپیتوفرونتالیس دارای دو بطن است: (شکل ۱) اکسیپیتال یا اکسیپیتالیس و فرونتال یا فرونتالیس. این دو بطن به آپونوروز اپی‌کرانیال منتهی می‌شوند. بطن‌های اکسیپیتال کوچک و جدا از هم هستند. هر دو بطن از ۲/۳ خارجی خط نوکال فوقانی منشأ می‌گیرند و شاخه اوریکولار خلفی (posterior auricular) عصب فاسیال به آنها عصب‌دهی می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

بطن‌های فرونتال این عضله بلندتر و پهن‌تر هستند و تا حدودی در صفحه میانی به یکدیگر می‌پیوندند. هر کدام از این بطن‌های عضلانی از پوست پیشانی آغاز شده و با عضلات مدور چشمی (orbicularis oculi) و چین‌دهنده ابرو (corrugator supercilliary) ادغام می‌شوند. شاخه تمپورال (Temporal branch) عصب فاسیال به این بطن عضله عصب‌دهی می‌کند.

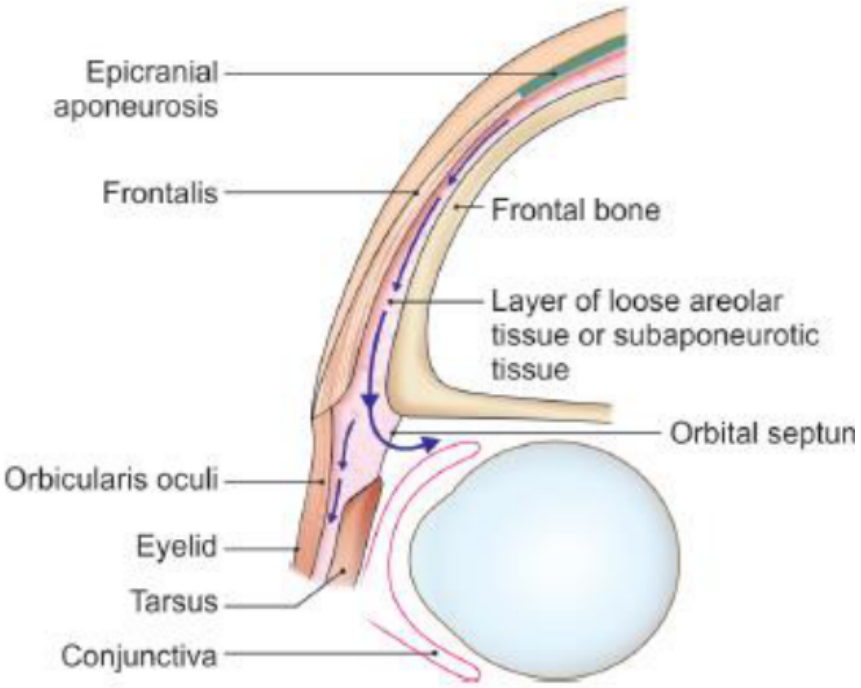
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

این عضله ابروها را بالا برده و چین‌های افقی در پوست پیشانی ایجاد می‌کند. آپونوروز اپی‌کرانیال یا نیام گالهآ همراه با پوست و فاسیای زیر خود بر روی پری‌کرانیوم آزادانه حرکت می‌کند شکل (۲). به این نیام در جلو عضله فرونتالیس و در خلف عضله اکسیپیتالیس منتهی می‌شوند. آپونوروز اپی‌کرانیال به برجستگی اکسیپیتال خارجی و خطوط نوکال فوقانی‌ترین در بین بطن‌های اکسیپیتال متصل می‌گردد. در هر طرف این آپونوروز به خط تمپورال فوقانی متصل شده و یک امتداد نازک از این نیام به سمت پایین طی مسیر کرده و از روی فاسیای تمپورال عبور کرده و به قوس زایگوماتیک متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

تصویر جزوه — ساختمان لایه‌ها و عضله اکسیپیتوفرونتالیس

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2، شکل 02



فضای زیرآپونوروتیک را در امتداد پلک فوقانی و ملتحمه دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2، شکل 02

سه لایه اول اسکالپ لایه‌های جراحی (surgical layers) اسکالپ نامیده می‌شوند. این لایه‌ها اسکالپ اصلی (scalp proper) نیز نام دارند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

نکته بالینی: چهارمین لایه اسکالپ از بافت همبند سست ساخته شده است. از آنجایی که عضله فرونتالیس هیچ اتصال استخوانی ندارد این لایه در جلو تا پلک‌ها امتداد (شکل ۲).

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

شکل (۲) برش شماتیک از اسکالپ و پلک فوقانی برای نشان دادن اینکه چگونه مایعات می‌توانند از فضای ساب آپوروتیک یا لایه بافت سست اسکالپ به درون پلک‌ها و ناحیه زیر ملتحمه انتقال یابند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

نکته بالینی: لایه چهارم اسکالپ در خلف تا خطوط نوکال فوقانی [ادامه در صفحه ۳].

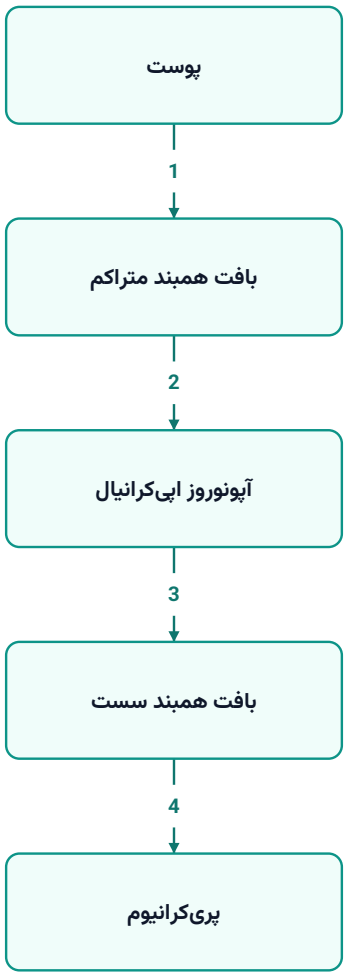
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در برش جزوه، فضای سست در عمق آپونوروز و مسیر به سمت پلک فوقانی نشان داده شده است.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۲، شکل ۲

- **نمودار رابطه‌ها — لایه‌ها و راه حرکت**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. پوست ← بافت همبند متراکم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در عمق
2. بافت همبند متراکم ← آپونوروز اپی‌کرانیال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در عمق
3. آپونوروز اپی‌کرانیال ← بافت همبند سست | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در عمق
4. بافت همبند سست ← پری‌کرانیوم | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در عمق

تمرین خواندن نمودار: رابطه هر پیکان را با متن و تصویر مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۲ و ۳، شکل‌های ۱ تا ۳

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — ساختمان لایه‌ها و عضله اکسیپیتوفرونتالیس
برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 2؛ جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۲، شکل ۲

- ☐ بطن‌های فرونتال و اکسیپیتال را به آپونوروز متصل کنید.
- ☐ فضای زیرآپونوروتیک را نسبت به پلک بالا بیابید.
- ☐ سه لایه جراحی را از لایه چهارم متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در برش جزوه، فضای سست در عمق آپونوروز و مسیر به سمت پلک فوقانی نشان داده شده است.

پرسش باز: بطن‌های فرونتال و اکسیپیتال را به آپونوروز متصل کنید؛ فضای زیرآپونوروتیک را نسبت به پلک بالا بیابید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی

مبحث ۳ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث
قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی

هدف یادگیری

پری‌کرانیوم و سینوس وریدی را نسبت به استخوان پیدا کنید؛ لایه‌های ناحیه تمپورال و عضله تمپورالیس را در نماها مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

پری‌کرانیوم و سینوس وریدی را نسبت به استخوان پیدا کنید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

می‌یابد. این لایه محل عبور وریدهای خروجی است که وریدهای خارج جمجمه‌ای را به سینوس‌های وریدی داخل جمجمه‌ای متصل می‌کنند (شکل ۳).

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

لایه پنجم اسکالپ، پری‌کرانیوم نام دارد که به سستی به سطح استخوان‌ها متصل می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

ناحیه تمپورال سطحی با اسکالپ توضیح داده می‌شود.

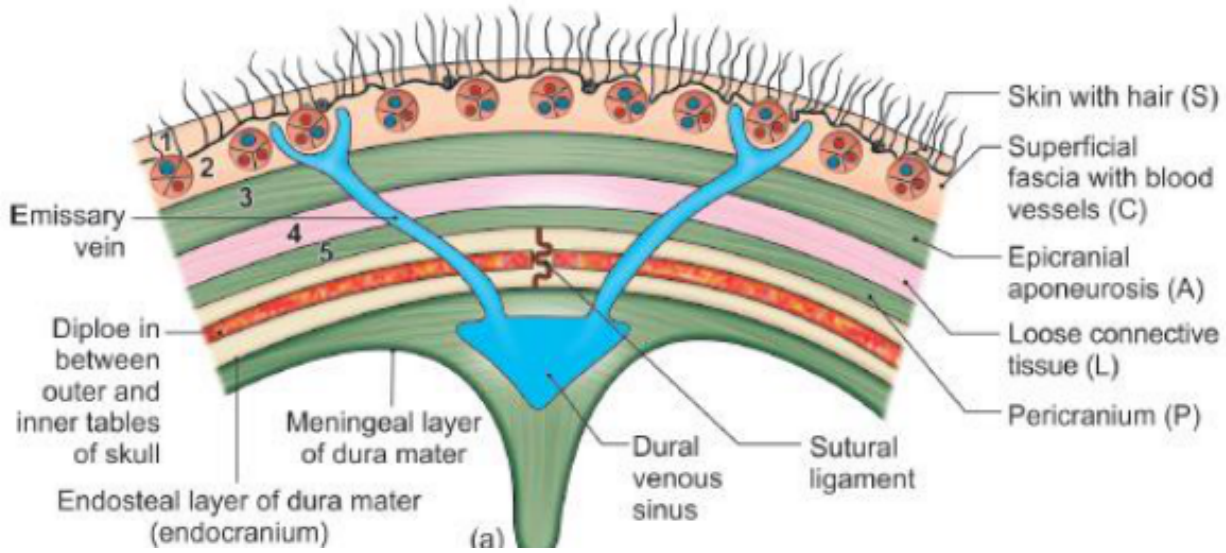
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

شکل (۳) لایه‌های اسکالپ و سینوس وریدی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

تصویر جزوه — پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3، شکل 03



ورید خروجی را از لایه سست تا سینوس وریدی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3، شکل 03

ناحیه تمپورال سطحی superficial temporal region در بین خط تمپورال فوقانی و قوس زایگوماتیک قرار گرفته است. در این ناحیه ۶ لایه زیر وجود دارند:

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

۱. پوست

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

۲. فاسیای سطحی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

امتداد نازکی از آپونوروز اپی‌کرانیال که محل مبدأ عضلات بیرونی (extrinsic) لاله گوش است.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

۴. فاسیای تمپورال

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

۵. عضله تمپورالیس

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

۶. پری‌کرانیوم

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

تمپوس (tempus) در لاتین به معنی زمان است. جوگندمی شدن مو در ابتدا از این ناحیه شروع می‌شود.

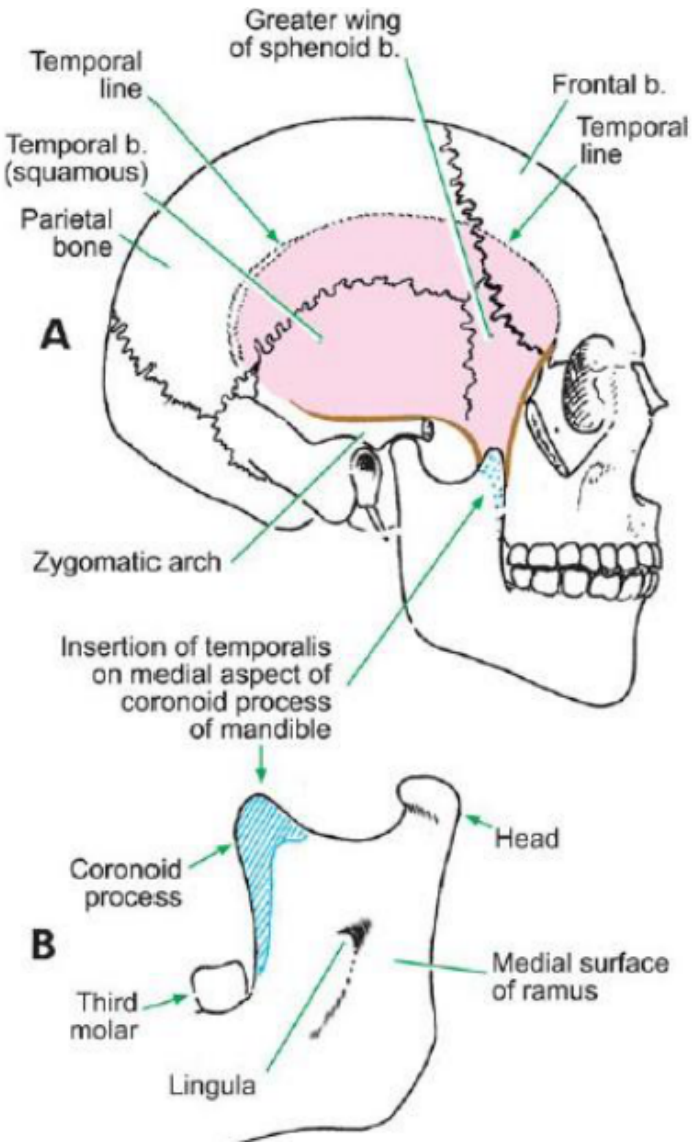
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

شکل (۴) اتصالات عضله تمپورالیس یا گیجگاهی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3

تصویر جزوه — پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3، شکل ۴

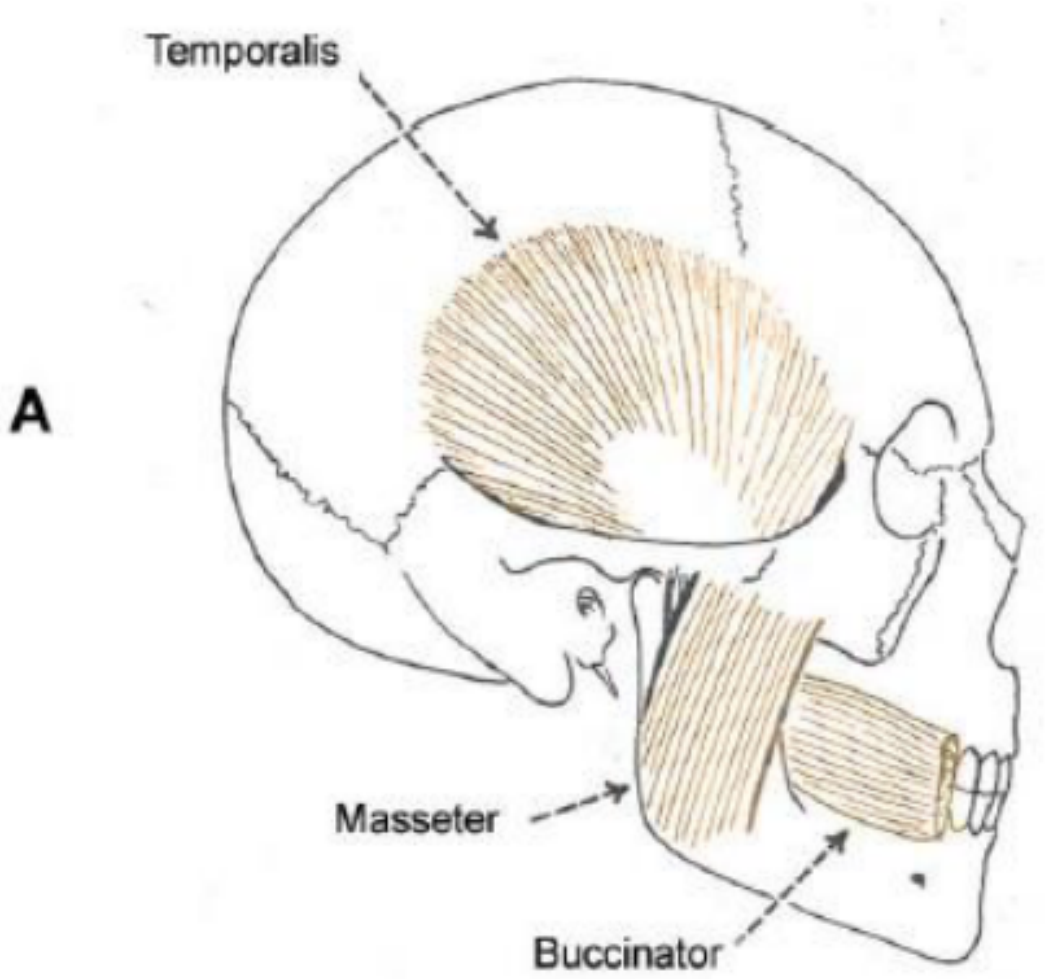


استخوان‌های محدوده گیجگاهی و محل اتصال عضله به زائده کرونوئید را مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3، شکل ۴

تصویر جزوه — پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3، شکل ۴



عضله تمپورالیس را نسبت به ماستر و بوکسیناتور در نمای جانبی ببینید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3، شکل ۴

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نمای عمقی و تصویر عضله را جداگانه بخوانید؛ شکل‌های صفحه ۳ و ۴ هر دو شماره ۴ دارند اما یکسان نیستند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۳، شکل‌های ۳ و ۴

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 3؛ جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۳، شکل‌های ۳ و ۴

- ☐ پری‌کرانیوم و سینوس وریدی را نسبت به استخوان پیدا کنید.
- ☐ لایه‌های ناحیه تمپورال و عضله تمپورالیس را در نماها مقایسه کنید.
- ☐ امتداد سطحی آپونوروز را از فاسیای تمپورال جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نمای عمقی و تصویر عضله را جداگانه بخوانید؛ شکل‌های صفحه ۳ و ۴ هر دو شماره ۴ دارند اما یکسان نیستند.

پرسش باز: پری‌کرانیوم و سینوس وریدی را نسبت به استخوان پیدا کنید؛ لایه‌های ناحیه تمپورال و عضله تمپورالیس را در نماها مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

خون‌رسانی اسکالپ و گیجگاه

مبحث ۴ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

خون‌رسانی اسکالپ و گیجگاه

هدف یادگیری

دو شاخه افتالمیک و شاخه‌های کاروتید خارجی را دسته‌بندی کنید؛ عروق پشت و جلوی گوش را بر روی تصویر دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

دو شاخه افتالمیک و شاخه‌های کاروتید خارجی را دسته‌بندی کنید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

خون‌رسانی اسکالپ و ناحیه تمپورال سطحی

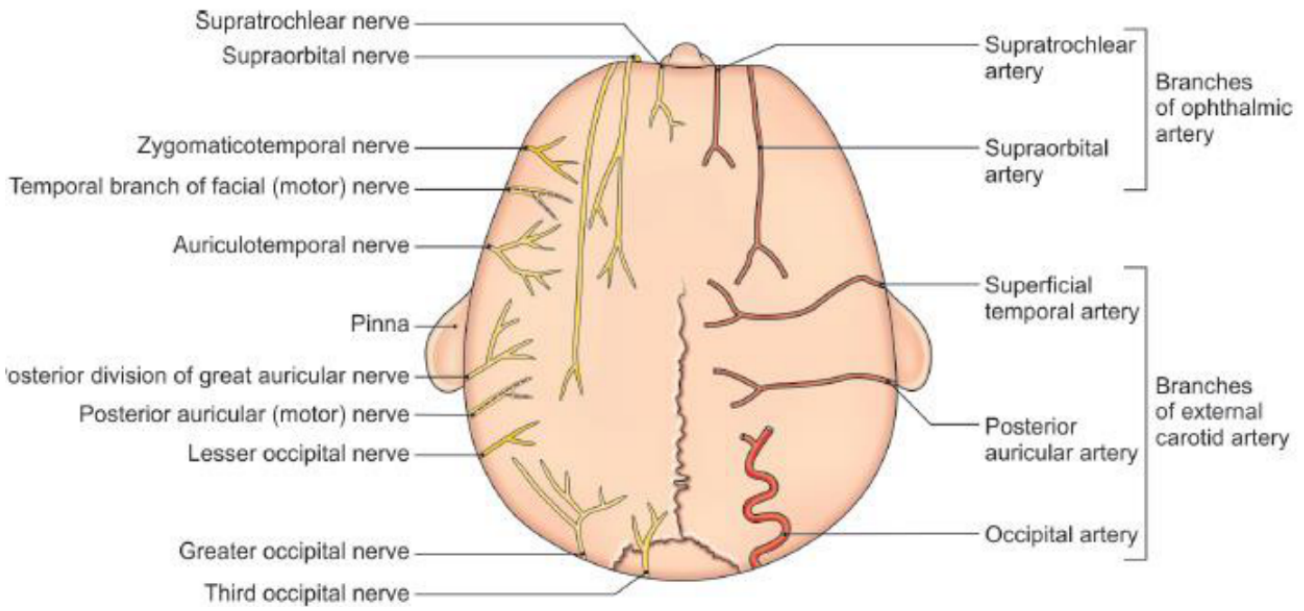
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

شکل (۴) خون‌رسانی و اعصاب ناحیه اسکالپ و تمپورال سطحی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

تصویر جزوه — خون‌رسانی اسکالپ و گیجگاه

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4، شکل ۴



عروق یک سمت و اعصاب سمت دیگر را با لاله گوش و خط میانی مقایسه کنید؛ ابتدای یک برچسب در خود اصل بریده است.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4، شکل ۴

اسکالپ توسط شریان‌های زیر خون‌رسانی می‌شود: (شکل ۴)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

- سوپراتروکلئار (supratrochlear)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

- سوپرااوربیتال (supraorbital)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

- تمپورال سطحی (superficial temporal)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

دو شریان اول شاخه‌های شریان افتالمیک (ophthalmic artery) که شاخه‌ای از شریان کاروتید درون است، می‌باشند. شریان تمپورال سطحی شاخه شریان کاروتید بیرونی است.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

در پشت لاله گوش، اسکالپ از عقب به جلو توسط شریان‌های زیر خون‌رسانی می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

• اوریکولار خلفی (Posterior auricular)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

• اکسیپیتال (Occipital) . هر دو شریان شاخه شریان کاروتید خارجی هستند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نتر رگ‌های سطحی تمپورال، اوریکولار خلفی و اکسیپیتال و نیز شاخه‌های بالای کاسه چشم را در نمای جانبی نشان می‌دهد.

منبع: نتر، پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

ابهام برای بازبین

در متن درس، دو شریان پشت گوش با عبارت «از عقب به جلو» و سپس به ترتیب اوریکولار خلفی و اکسیپیتال آمده‌اند. جهت این ترتیب را با نمای نتر و جهت گوش مقایسه کنید؛ این مورد برای بازبین باز می‌ماند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۴؛ نتر، پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — خون‌رسانی اسکالپ و گیجگاه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 4؛ نتر، پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

- ☐ دو شاخه افتالمیک و شاخه‌های کاروتید خارجی را دسته‌بندی کنید.
- ☐ عروق پشت و جلوی گوش را بر روی تصویر دنبال کنید.
- ☐ منشأ شاخه‌ها را با نقشه نتر تطبیق دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نتر رگ‌های سطحی تمپورال، اوریکولار خلفی و اکسیپیتال و نیز شاخه‌های بالای کاسه چشم را در نمای جانبی نشان می‌دهد.

پرسش باز: دو شاخه افتالمیک و شاخه‌های کاروتید خارجی را دسته‌بندی کنید؛ عروق پشت و جلوی گوش را بر روی تصویر دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تخلیه وریدی

مبحث ۵ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

تخلیه وریدی

هدف یادگیری

سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار را تا ورید زاویه‌ای دنبال کنید؛ دو انشعاب رترومندیبولار و مقصد هر یک را تفکیک کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار را تا ورید زاویه‌ای دنبال کنید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

بنابراین اسکالپ خون‌رسانی غنی از شاخه‌های شریان‌های کاروتید درونی و بیرونی دارد. دو شریان کاروتید درون و بیرونی بر روی ناحیه گیجگاهی (تمپورال) با یکدیگر آناستوموز می‌دهند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

تخلیه وریدی (شکل ۵)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

وریدهای اسکالپ شریان‌ها را همراهی کرده و همنام این شریان‌ها هستند. وریدهای سوپراتروکلئار و سوپرااوربیتال در زاویه داخلی چشم به یکدیگر پیوسته و ورید زاویه‌ای (angular vein) را می‌سازند. این ورید نیز در پایین تحت عنوان ورید فاسیال ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

ورید تمپورال سطحی در جلوی تراگوس وارد غده پاروتید می‌شود و در نسج این غده به ورید ماگزیلاری پیوسته و ورید رترومندیبولار (retromandibular) را تشکیل می‌دهد. این ورید نیز به دو شاخه تقسیم می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

شاخه قدامی ورید رترومندیبولار با ورید فاسیال یکی شده و ورید صورتی مشترک (common facial vein) را که به جوگولار درون (internal jugular vein) تخلیه می‌شود، تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

شاخه خلفی ورید رترومندیبولار با ورید اوریکولار خلفی (posterior auricular vein) یکی شده و ورید جوگولار بیرونی (external jugular vein) را تشکیل می‌دهد. ورید جوگولار بیرونی نیز نهایتا به ورید ساب‌کلاوین (subclavian vein) تخلیه می‌شود. وریدهای اکسیپیتال به شبکه وریدی ساب‌اکسیپیتال منتهی می‌شوند (شکل ۵).

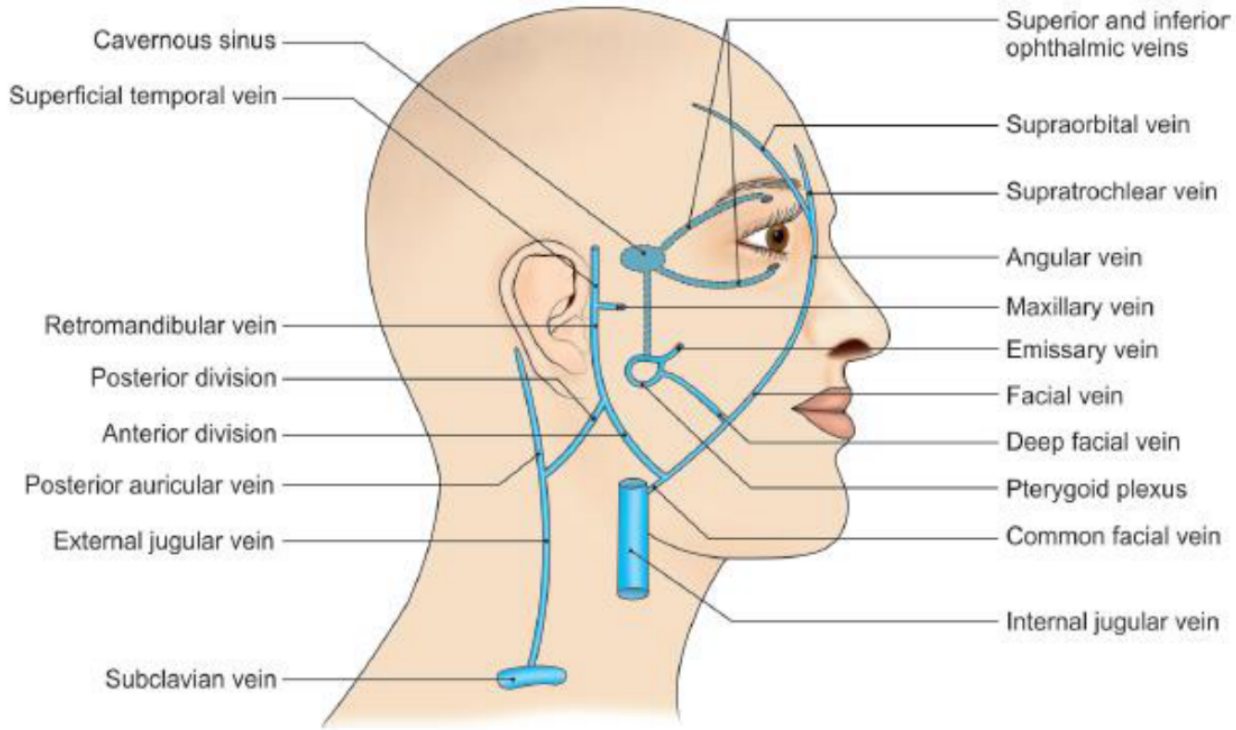
منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

شکل (۵) تخلیه وریدی اسکالپ و تمپورال سطحی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — تخلیه وریدی

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5، شکل ۵



وریدهای صورت و دو شاخه رترومندیبولار را تا وریدهای ژوگولار دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5، شکل ۵

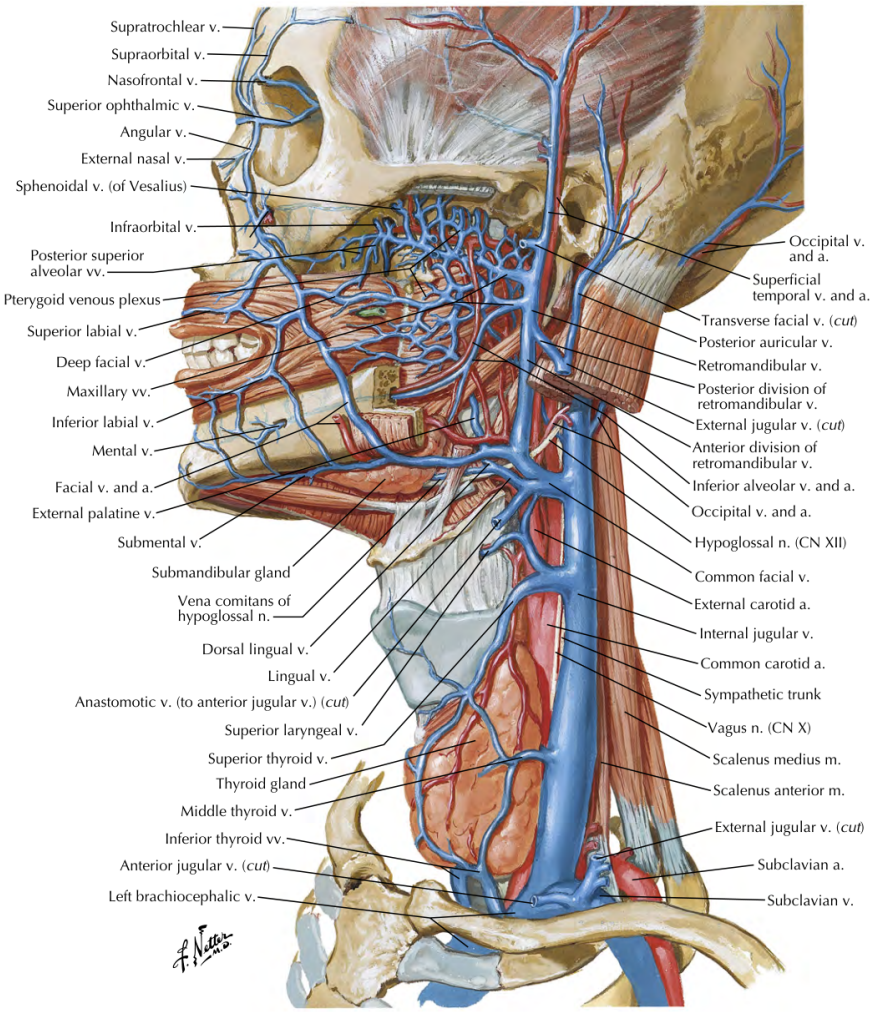
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در نتر شاخه‌های قدامی و خلفی ورید رترومندیبولار را در ارتباط با ژوگولارها و ورید صورتی مقایسه کنید.

منبع: نتر، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل ۱۵۲

نمای مرجع — تخلیه وریدی

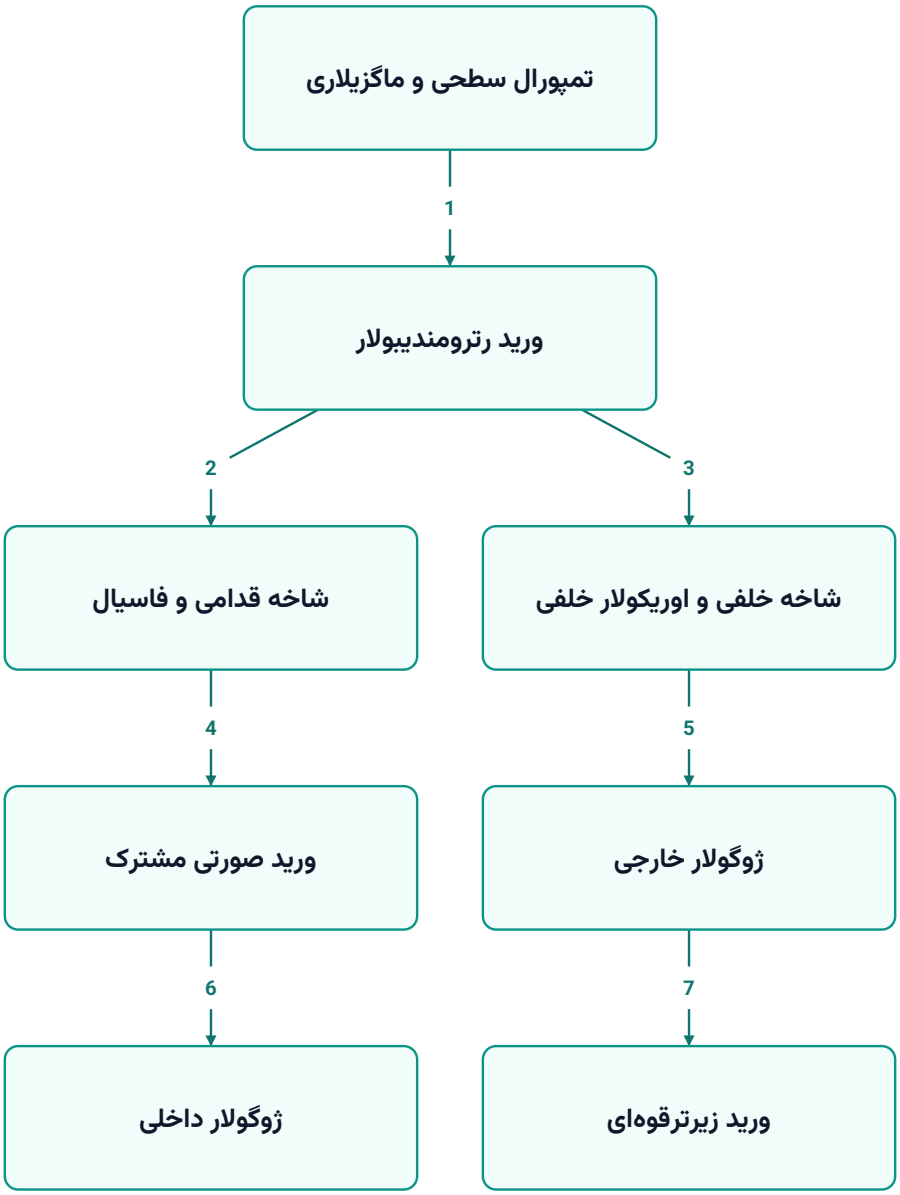
نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل 152



ورید رترومندیبولار و دو شاخه آن را نسبت به ژوگولارها دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل 152

- **نمودار رابطه‌ها — تخلیه ورید ترومندیبولار**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. تمپورال سطحی و ماگزیلاری ← ورید ترومندیبولار | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد
2. ورید ترومندیبولار ← شاخه قدامی و فاسیال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
3. ورید ترومندیبولار ← شاخه خلفی و اوریکولار خلفی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
4. شاخه قدامی و فاسیال ← ورید صورتی مشترک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد
5. شاخه خلفی و اوریکولار خلفی ← ژوگولار خارجی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد
6. ورید صورتی مشترک ← ژوگولار داخلی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تخلیه
7. ژوگولار خارجی ← ورید زیرترقوه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تخلیه

تمرین خواندن نمودار: رابطه هر پیکان را با متن و تصویر مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۵؛ نتر، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل ۱۵۲

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — تخلیه وریدی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 5؛ نتر، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل ۱۵۲

- ☐ سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار را تا ورید زاویه‌ای دنبال کنید.
- ☐ دو انشعاب رترومندیبولار و مقصد هر یک را تفکیک کنید.
- ☐ تخلیه ژوگولار خارجی را تا زیرترقوه‌ای دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در نتر شاخه‌های قدامی و خلفی ورید رترومندیبولار را در ارتباط با ژوگولارها و ورید صورتی مقایسه کنید.

پرسش باز: سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار را تا ورید زاویه‌ای دنبال کنید؛ دو انشعاب رترومندیبولار و مقصد هر یک را تفکیک کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

وریدهای رابط و عصب‌دهی

مبحث ۶ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

وریدهای رابط و عصب‌دهی

هدف یادگیری

وریدهای رابط جداری و ماستوئید را با سینوس مقصد تطبیق دهید؛ چهار عصب حسی جلو و چهار عصب حسی عقب گوش را مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

وریدهای رابط جداری و ماستوئید را با سینوس مقصد تطبیق دهید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

نکته بالینی: وریدهای بیرون جمجمه‌ای از طریق وریدهای emissary یا خروجی به سینوس‌های وریدی درون جمجمه‌ای مرتبط شده و فشار را متعادل می‌کنند. ورید emissary پریتال از طریق سوراخ پریتال به سینوس ساژیتال فوقانی می‌پیوندد. ورید خروجی ماستوئید از سوراخ ماستوئید عبور کرده و به سینوس سیگموئید می‌رسد. عفونت‌های خارج جمجمه‌ای ممکن است از طریق این وریدهای emissary به سینوس‌های وریدی درون جمجمه‌ای انتشار یابند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

عصب‌دهی اسکالپ و ناحیه تمپورال سطحی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

عصب‌دهی اسکالپ و ناحیه گیجگاه در هر طرف توسط ده عصب انجام می‌شود. ۵ عدد از این اعصاب (که ۴ عصب حسی و یک عصب حرکتی است) در جلوی لاله گوش و ۵ عصب دیگر (دوباره ۴ عصب حسی و یک عصب حرکتی است) از پشت لاله گوش وارد اسکالپ می‌شوند (شکل ۴).

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

در جلوی لاله گوش؛ اعصاب حسی:

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• سوپراتروکلئار، شاخه‌ای از عصب فرونتال (جدا شده از انشعاب افتالمیک عصب تری‌ژمینال)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• سوپرااوربیتال، شاخه‌ای از عصب فرونتال (جدا شده از انشعاب افتالمیک عصب تری‌ژمینال)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• زایگوماتیکوتمپورال، شاخه‌ای از عصب زایگوماتیک (جدا شده از انشعاب ماگزیلاری عصب تری‌ژمینال)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• شاخه اوریکولوتمپورال، شاخه‌ای از انشعاب مندیبولار عصب تری‌ژمینال

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

عصب حرکتی: شاخه تمپورال عصب فاسیال

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

در عقب لاله گوش؛ اعصاب حسی:

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• انشعاب خلفی عصب اوریکولار بزرگ (C2 و C3) ، شاخه‌ای از شبکه عصبی گردنی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• عصب اکسیپیتال کوچک (C2) ، شاخه‌ای از شبکه عصبی گردنی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• عصب اکسیپیتال بزرگ (C2، شاخه پشتی)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

• عصب اکسیپیتال سوم (C3، شاخه پشتی)

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

عصب حرکتی: شاخه اوریکولار خلفی عصب فاسیال

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6

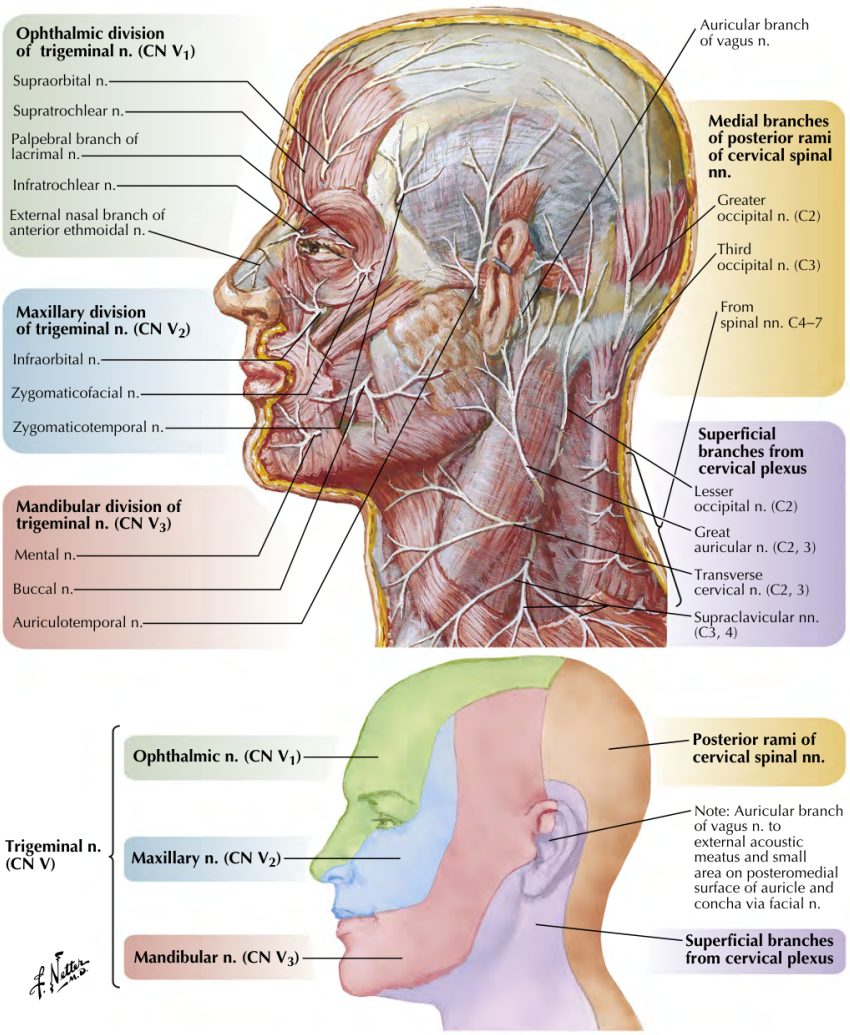
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نتر اعصاب پوستی جلوی گوش را در قلمرو شاخه‌های سه‌قلو و اعصاب خلفی را در قلمرو اعصاب گردنی نشان می‌دهد؛ نقشه حسی جای عصب حرکتی فاسیال نیست.

منبع: نتر، پلیت ۲۳، صفحه فایل ۷۵؛ پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

نمای مرجع — وریدهای رابط و عصب‌دهی

نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۲۳، صفحه فایل 75



نقشه اعصاب پوستی سه‌قلو و گردنی را نسبت به گوش مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۲۳، صفحه فایل 75

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — وریدهای رابط و عصب‌دهی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 6؛ نتر، پلیت ۲۳، صفحه فایل ۷۵؛ پلیت ۲۴، صفحه فایل ۷۶

- ☐ وریدهای رابط جداری و ماستوئید را با سینوس مقصد تطبیق دهید.
- ☐ چهار عصب حسی جلو و چهار عصب حسی عقب گوش را مقایسه کنید.
- ☐ شاخه‌های حرکتی فاسیال را از اعصاب حسی جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نتر اعصاب پوستی جلوی گوش را در قلمرو شاخه‌های سه‌قلو و اعصاب خلفی را در قلمرو اعصاب گردنی نشان می‌دهد؛ نقشه حسی جای عصب حرکتی فاسیال نیست.

پرسش باز: وریدهای رابط جداری و ماستوئید را با سینوس مقصد تطبیق دهید؛ چهار عصب حسی جلو و چهار عصب حسی عقب گوش را مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نکات بالینی اسکالپ

مبحث ۷ از ۷ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نکات بالینی اسکالپ

هدف یادگیری

فضای بافت سست را با راه انتشار مایع و عفونت مرتبط کنید؛ سفال‌هماتوما را با کبودی پلک و درزها مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های سر، استخوان‌های جمجمه و شبکه عروقی سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

فضای بافت سست را با راه انتشار مایع و عفونت مرتبط کنید.

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی در ادامه نقل درس‌اند؛ برای تصمیم‌گیری درباره بیمار یا انجام مداخله از آن‌ها به‌تنهایی استفاده نکنید.

نکات بالینی

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- به دلیل فراوان بودن غدد سباسه (چربی)، در اسکالپ، این ناحیه محل شایعی برای کیست‌های سباسه (sebaceous cysts) است (شکل ۵).

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

تصویر جزوه — نکات بالینی اسکالپ

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7، شکل ۵



تصویر بالینی را در کنار توضیح جزوه درباره کیست‌های اسکالپ بخوانید، نه به‌عنوان تشخیص قطعی تصویر.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7، شکل ۵

شکل (۵) غدد سباسه در اسکالپ.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- زخم‌های ایجاد شده در اسکالپ با خونریزی شدید همراه هستند زیرا که فاسیای فیبروزی از انقباض و جمع شدن عروق جلوگیری می‌کند. برای کنترل خونریزی می‌توان در بالای گوش‌ها توسط یک بانداژ کتان محکم بر روی استخوان فشار وارد کرد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- خونریزی‌های زیر پوستی به دلیل تراکم فاسیا هرگز پخش نمی‌شوند و التهاب در این لایه با تورم اندک ولی درد بسیار همراه می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- از آنجایی که پری‌کرانیوم به درزها متصل شده است، به تجمع مایع در عمق پری‌کرانیوم، سفال هماتوما (cephalhaematoma) گفته می‌شود که به شکل استخوان زیرین خود است.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- لایه بافت آئولوار سست یک ناحیه خطرناک در اسکالپ می‌باشد زیرا وریدهای خروجی که از این محل عبور می‌کنند، می‌توانند عفونت را از اسکالپ به سینوس‌های وریدی کرانیال منتقل کنند (شکل ۳).

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- تجمع خون در لایه بافت همبند سست دلیل تورم عمومی اسکالپ می‌باشد. خون در جلد می‌تواند تا ریشه بینی و تا پلک‌ها امتداد یابد و منجر به کبودی چشم (black eye) شود. دلیل این مسئله عدم وجود اتصال استخوانی عضله فرونتالیس است (شکل ۶). حد خلفی گسترش خونریزی دیده نمی‌شود. اگر خونریزی به علت آسیب موضعی باشد، حد خلفی خونریزی نیز رؤیت می‌گردد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

تصویر جزوه — نکات بالینی اسکالپ

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7، شکل clinical_06



کبودی اطراف چشم را با امتداد فضای سست در شکل ۲ مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7، شکل clinical_06

شکل (۶) کبودی چشم به دلیل جراحت وارده با اسکالپ

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

- به دلیل خون‌رسانی غنی اسکالپ و ناحیه تمپورال سطحی، بخش‌های بدون رگ نیازی به بریده‌شدن و برداشته‌شدن ندارند. این بخش‌ها در محل خود حفظ شده و بخیه زده می‌شوند که معمولا به خوبی بهبود می‌یابند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

لایه همبند سست و اتصال پری‌کرانیوم به درزها دو رابطه متفاوت‌اند؛ عبارات بالینی متن برای شناخت درس است و جای ارزیابی بیمار یا دستور درمان را نمی‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۷

پرسش باز برای بازبین

جمله‌های مطلق درباره پخش‌نشدن خونریزی زیرپوستی و حفظ بخش‌های بدون رگ، عین محتوای درس‌اند؛ محدوده اعتبار و تعبیر بالینی آن‌ها باید بررسی شود و نباید به‌تنهایی راهنمای درمان تلقی شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۷

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — نکات بالینی اسکالپ

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل 7؛ جزوه جلسه ۱۰، صفحه فایل ۷

- ☐ فضای بافت سست را با راه انتشار مایع و عفونت مرتبط کنید.
- ☐ سفال‌هماتوما را با کبودی پلک و درزها مقایسه کنید.
- ☐ گفته‌های بالینی جزوه را از دستور مراقبت بیمار متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

لایه همبند سست و اتصال پری‌کرانیوم به درزها دو رابطه متفاوت‌اند؛ عبارات بالینی متن برای شناخت درس است و جای ارزیابی بیمار یا دستور درمان را نمی‌گیرد.

پرسش باز: فضای بافت سست را با راه انتشار مایع و عفونت مرتبط کنید؛ سفال‌هماتوما را با کبودی پلک و درزها مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — حدود و لایه‌های اسکالپ	حدود قدامی، خلفی و طرفی اسکالپ را مشخص کنید.	☐
مبحث ۲ — ساختمان لایه‌ها و عضله اکسیپیتوفرونتالیس	بطن‌های فرونتال و اکسیپیتال را به آپونوروز متصل کنید.	☐
مبحث ۳ — پری‌کرانیوم و ناحیه تمپورال سطحی	پری‌کرانیوم و سینوس وریدی را نسبت به استخوان پیدا کنید.	☐
مبحث ۴ — خون‌رسانی اسکالپ و گیجگاه	دو شاخه افتالمیک و شاخه‌های کاروتید خارجی را دسته‌بندی کنید.	☐
مبحث ۵ — تخلیه وریدی	سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار را تا ورید زاویه‌ای دنبال کنید.	☐
مبحث ۶ — وریدهای رابط و عصب‌دهی	وریدهای رابط جداری و ماستوئید را با سینوس مقصد تطبیق دهید.	☐
مبحث ۷ — نکات بالینی اسکالپ	فضای بافت سست را با راه انتشار مایع و عفونت مرتبط کنید.	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۰

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۱۱: صورت.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۱۰ از ۱۳ — اسکالپ و ناحیه تمپورال

تصویرها از جزوه و نتر · متن از جزوه درس